

NS

JOHN DOS SANTOS CARAÇA

IDADE: 20 PESO: 84 ALTURA: 1,77 PROFISSÃO: Estudante
 SINTOMAS: Cansaço / sonolência / Refluxo raro ^{exonomia}
 QUEIXAS: (EAD)
 MEDICAMENTOS: Alecrim / Tamoxifeno / Entroid / Imens.
 insônia / ansiedade / sonolência
 EXERCÍCIO FÍSICO: não (fisioterapia 2x)
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S
 HORA QUE DORME: 1:30 HORA QUE ACORDA: 10hs
 COCHILLO (X)SIM ()NÃO 2m DORME ACOMPANHADO ()SIM ()NÃO ()EVENTUAL
 BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA (X)NÃO
 FUMO (X)SIM ()MAÇO/DIA ()NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: -
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 3x à 5x
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
 OVERLAP: MALLAMPATI: IV IAH: 37.9 SPO2: 76%
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS: não
 CIRURGIAS: ()NASAL ()AMIGDALECTOMIA Sonolência 0
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não
 COMORBIDADE: (X)RESPIRATÓRIA ^{ansiosa} (X)ENDÓCRINA (N)CARDÍACA
 (N)ORTOPÉDICA (X)NEUROLÓGICA ^{de pressão} OUTROS Desmoldes (desco-
 briu há 1 ano / mudou a vez p/ nasal.
 10/04/23 Início do uso do CPAP. ^{fue}

Presso C3 e C5 desloca a jugular
 Tem 10 cm de TV.

P = 4-7 cmH₂O - Másc. DreamWear Small.

14/04 1º dia → Dormiu 5 horas - SIC mãe - elevou cabeça
 23 2º dia → Dormiu 6 horas - SIC mãe - " "
 Cansaço aos esforços, ↓ as intensidade dos exerc.
 Psiquiatria → orientou o uso de ansiolíticos.
 Troquei o CPAP p/ S10 autom. (5-12 cmH₂O)
 Banheiro 1 à 2x no máximo
 Início dormindo do lado (D).
 elevou 10 cm da cabeça, perdi p/ elevar +5 cm.
 Arefagia e gases.
 Fez 1 dia sem outro não.
 ↑ o nº de horas de uso.
 ↑ a pressão inicial p/ 5 cmH₂O, houve melhora no relacionamento do casal.

17/05 P = 4 6 cmH₂O ^{menor mínima} (inicial p/ 5)
 12 ~~4~~ cmH₂O a máxima manteve. ^{fue}

31/07 P = 13 cmH₂O
 23 IAH = 11.7 elev
 m. de uso: 8hs → dormindo
 Bem adapt. ^{fue}

25/09 - P = 13,0 max. (min = 10 cmH₂O)

23 IAH = 10,5

M. de uso: 7h50'

ajuste pressão (12 min) e 14 cmH₂O (max)
houve redução do TV.

lua

21/11
23
Whatts

P = 14-12 autom. (med - 13,4 / Perc 13,9)
IAH = 8,6 (AC = 0,4 / IH = 1,1 / AO = 0,8)
P = 15-13 cmH₂O
Pi = 8 cmH₂O

lua

27/11
23

P = 12 x 14 cmH₂O

IAH = 8,6 e/ou

M. de uso: 8h40'

Voltou a estudar, está dormindo de lado.

comunico sobre o CPAP

lua.

14/03
24

P = 12 cmH₂O

IAH = 9,8 cmH₂O

M. de uso: 8h13

- ajuste o CPAP

- melhora do cansaço.

- ainda tem dor.

13/06
24

P =

27/06
25

P =

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: JOHN DOS SANTOS CARAÇA			
Sexo: M	Idade: 20 anos	Peso: 83 Kg	Altura: 1,77 m
IMC: 26,5	Data do Exame: 20/03/2023	Exame: 12281_01	
Médico solicitante: DR MARIO SERGIO			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 21:00:47 horas e encerrado às 06:01:51 horas, com latência para o sono de 231 minutos e latência para o sono REM de 124 minutos. O tempo total de sono foi de 194,5 minutos, com eficiência do sono de 38,6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	9,8%	Até 5%
Estágio 2	59,6%	45 - 55%
Estágio 3	29,0%	> 15%
Sono REM	1,5%	20 - 25%
Eficiência do sono	38,6%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 259 minutos ocorreram **71 despertares (índice de 21,9 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 84 bpm, a maior de 119 bpm e a menor de 58 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora**, e **0,0/hora associados a despertares**.

Ocorreram 123 eventos respiratórios, sendo 0 central e 123 obstrutivos. Sendo 104 apnéias, 19 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 37,9/hora**, sendo 32,1 apnéia/hora e 5,9 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 17,4 e a duração máxima de 40,4.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 20,0/hora, sendo 0,0 apnéia/hora e 20,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 94%**, sendo a saturação média de 93%, a maior de 97% e a mínima de 76%, permanecendo 12,4 minutos (2,5%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,1 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 55 dessaturações. Índice de dessaturações: 17,0/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 40,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 17,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71260

48

HMJCF- Hospital Mun. Dr. José de Carvalho
R SAIGIRO NAKAMURA, 800 - SÃO JOSE DOS CAMPOS

25/03/2022 12:35:47

"Esta conta será paga com recursos Públicos Provenientes de seus Impostos e Contribuições Sociais"

RESUMO DE ALTA MÉDICA - RELATÓRIO MÉDICO

Identificação do Paciente	Data / Hora Alta Médica: 25/03/2022 17:34:00
RH: 0001126727	Sexo: Masculino
NOME: John dos Santos Caraca	Data Nascimento: 23/11/2002
Utilizou Material de Consignação:	Idade: 19a 4m 2d
Tempo de Internação: 1 Dia(s)	Data/Hora Internação: 24/03/2022 17:26
COND. DE SAÍDA: Alta	Retorno:
Histórico Clínico	Atend.: 23525915
# PO BIOSPSIA DE MASSA CERVICAL SEM INTERCORRENCIAS	
Evolução Clínica	
Exames Laboratoriais	
Exames de Imagem	
Tratamentos Realizados	
Diagnósticos	
R229-TUMEFACAO, MASSA OU TUMORACAO NAO ESPECIFICADAS, LOCALIZADAS	
R599-ADENOMEGALIA OU AUMENTO DE VOLUME DOS GANGLIOS LINFATICOS, NAO ESPECIFICADO	
Orientação e Terapêutica	
RETORNO EM 14 DIAS COM DR EVANDRO	

Nome do Médico: EVANDRO LIMA E SILVA

CRM/CRO: 150674

Data/Hora Saída Hosp.: ____/____/____

Ass. Pac./Resp.: _____

Encaminhamento

Dr. Evandro Lima e Silva
CRM 150674
Cirurgião de Cabeça e Pescoço

Paciente: **JOHN DOS SANTOS CARACA (20 anos)**
Convênio: **Bradesco**
Matricula: **894258200019029**

Relatorio medico.

Realizado oroscopia com Malampati IV, não se visualizando os bordos do palato mole e base de úvula.
Videonasofibrilaringoscopia apresenta fossas nasais permeáveis, sem desvios significativos, meatos livres. Cavum já se observa inico do abaulamento da parede lateral da rinofaringe. Estreitamento das VAS ao nível de palato mole e da base da lingua com componente da parede posterior da rino e orofaringe e talvez laringofaringe. A epiglote se encontra colapsada com a parede posterior, não se observando a fenda glotica, as valeculas e nem os seios piriformes. A respiração se dá pelas fendas lateralmente à epiglote. Exame gravado.

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista

CRM 57250

15/02/23

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

Nome: **JOHN DOS SANTOS CARAÇA**
Solicitante: Dr(a): ALICE NAYANE ROSA MORAIS Data: 08/03/2023
Prontuário: 1404131 Atendimento: 013 - 0432530 Nasc: 23/11/2002

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA E REGIÃO CERVICAL

TÉCNICA:

Exame realizado com seqüências multiplanares: TSE T2 e T1, Balance e GRE T2.

Após a administração endovenosa do gadolínio foram obtidas seqüências ponderadas em T1.

ANÁLISE:

Volumosa formação expansiva de contornos lobulados e com intensa impregnação após a administração do meio de contraste venoso, ocupando o espaço pré-vertebral cervical desde o nível da orofaringe até a fossa supraclavicular direita. As medidas desta lesão são 17 x 8,8 x 6,5 cm (craniocaudal, lateral e anteroposterior).

A lesão esta íntima relação a cortical anterior dos corpos vertebrais cervicais e determina erosão/invasão nos corpos vertebrais de C2, C3 e C4.

Há também comprometimento dos forames transversos, ficando em íntima relação com a artéria vertebral direita, no segmento compreendido de C3 a C5. Não se observa alteração da intensidade de sinal de fluxo ou diâmetro da artéria vertebral direita.

Há importante deslocamento das estruturas cervicais no sentido anterior e lateral esquerdo, notadamente da laringe, faringe, traqueia, esôfago e artéria carótida interna direita.

Inversão do eixo anteroposterior cervical.

Desidratação parcial dos discos intervertebrais cervicais.

Abaulamentos discais posteriores de C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7 determinando leves compressões no saco dural.

Arcos posteriores íntegros. Articulações uncovertebrais e interapofisárias sem alterações.

A medula tem forma, volume e intensidade de sinal habituais.

O diâmetro do canal raquiano é de dimensões normais por toda extensão estudada.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame de controle de lesão expansiva cervical, Fibromatose desmoide, segundo informações clínicas.

Maira S. Tubagi

DRA MAIRA S. TUBAGI - CRM 119554

Faça também seus exames de sangue e laboratoriais conosco.

Avenida Andrômeda, 227 - Jardim Satélite, São José dos Campos-SP, 12230-000 - Telefone: (12) 3797-5411

NOME:
D.N:
SOLICITANTE:
CONVÊNIO:
LOCAL:

JOHN DOS SANTOS CARACA
23/11/2002
FANNY G A CASCELLI
BRADESCO SAÚDE S/A
JACAREI

O.S.: 296-66557-216
CPF: 387.356.598-66
ATENDIMENTO: 24/03/2023 - 09:09:38
QTD DE EXAMES: 9
PAGINA(S): 4/4

HEMOGRAMA

Material: Sangue total com EDTA

ERITROGRAMA

Eritrócitos: 5,0 milhões/mm³
Hemoglobina: 15,4 g/dL
Hematócrito: 45,5 %
V.C.M.: 90,6 fL
H.C.M.: 30,7 pg
C.H.C.M.: 33,8 g/dL
RDW: 13,4 %

valor de referência:

4,1 a 5,6 milhões/mm³
12,5 a 17,0 g/dL
37,5 a 51,0 %
80,0 a 99,9 ?m
23,8 a 33,4
32,0 a 36,0
11,0 a 14,5

LEUCOGRAMA

Leucócitos: 7.200 /mm³
Bastonetes: 0,0 %
Segmentados: 47,9 %
Eosinófilos: 2,5 %
Basófilos: 0,5 %
Linfócitos Típicos: 40,6 %
Linfócitos Atípicos: 0,0 %
Monócitos: 8,5 %

valor de referência:

3.600 a 11.000/mm³
0 a 5
0 a 390
1.700 a 7.600
1 a 5
20 a 500
0 a 2
1.000 a 4.500
0 a 0
2 a 10
100 a 1.000

Plaquetas:

313.000 /mm³

140.000 a 450.000 /mm³

Coleta: 24/03/2023 - 09:18:33
Liberação: 24/03/2023 - 13:14:35

Laudo assinado eletronicamente por Bruna Daniela Pereira de Moraes, CRBM 33475.
ASSINATURA DIGITAL
306A53ECE49604E305C501CF0FC6038B8A8C4ECFFDBD1E0F7274DE8C701970F120CF5D72CF069B4
Dr. Carlos Eduardo de Godoy (RT) - CRM 23287
A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão do diagnóstico são atos médicos; dependem da análise conjunta dos dados clínicos, epidemiológicos e dos demais exames do(a) paciente.

CLÍNICA DE IMAGEM

Dra. Odivanía Moscoliato

Ultrassonografia Mamografia Densitometria

PACIENTE: JONH DOS SANTOS CARASAS
IDADE: 19 ANOS
MÉD. REQUIS.: DR WALNYR DE OLIVEIRA COSTA

DATA: 23/03/2022
PROTOCOLO: 124239

ULTRASSOM DA REGIÃO CERVICAL ANTERIOR

Exame realizado em tempo real, aparelho Canon, com transdutor linear multifrequencial de 5 a 11MHz.

Reposição hormonal: nega;

Indicação clínica: "avaliação de nódulo palpável na região lateral direita, que apareceu há 2 semanas e que teve aumento importante há 24 horas (SIC)"

Tireóide:

Lobo direito: medindo 4,8 x 1,6 x 1,5 cm nos maiores eixos.

Formato fusiforme e contornos regulares.

Textura sólida e homogênea.

Istmo: medindo 1,4 x 1,0 x 0,2 cm nos maiores eixos e apresentando aspecto textural normal.

Lobo esquerdo: medindo 4,9 x 1,7 x 1,4 cm nos maiores eixos.

Formato fusiforme e contornos regulares.

Textura sólida e homogênea.

Achado adicional: no rastreamento da região cervical direita, observa-se ocupando a face anterior (rechaça ântero-superiormente o lobo tireoideano direito), toda a face lateral e parte da face posterior cervical, extensa massa palpável, de aspecto globoso, lobulada, de contornos imprecisos, com textura sólida, ipoecogênica e muito heterogênea, devido a presença de focos de calcificação grosseira no seu interior. Desloca a carótida comum medialmente e a veia jugular ântero-superiormente; não havendo evidência de trombose da veia jugular neste exame. Mediu em conjunto aproximadamente 11,8 x 8,1 x 5,3 cm nos maiores eixos, com volume de 262,4cc.

Avaliação da vascularização ao Doppler colorido e de amplitude:

Foi realizado Doppler colorido e power angio, que revelou:

- normovascularização da glândula;
- moderada hipervascularização da massa, principalmente na sua face anterior.

CLÍNICA DE IMAGEM
Dra. Odivânia Moscoliato

Ultrassonografia Mamografia Densitometria

PACIENTE: JONH DOS SANTOS CARASAS
IDADE: 19 ANOS
MÉD. REQUIS.: DR WALNYR DE OLIVEIRA COSTA

DATA: 23/03/2022
PROTOCOLO: 124238

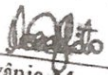
visitante: WALNYR
realizante: ODIVÂNIA

CONCLUSÃO:

- 1) Tireoide com dimensões e aspecto textural normais. Volume tireoideano global estimado em **11,1 cc** (normal – 11,5 +/- 3 cc).
- 2) Não há evidência de nódulo cístico, misto ou sólido intratireoideano no exame atual.
- 3) Os aspectos ecográficos e Dopplerfluxométricos descritos para a massa acima descrita (vide localização e descrição no corpo do laudo), com 8,4 cm de diâmetro médio e com 262,4 cc, são compatíveis com os processos primários, sendo que deve-se considerar:
 - a) processo expansivo primário linfoproliferativo;
 - b) gânglio metastático.
- 4) Não há evidência de gânglios suspeitos nos níveis I, II, III, IV, V, VI bilateral no exame atual.

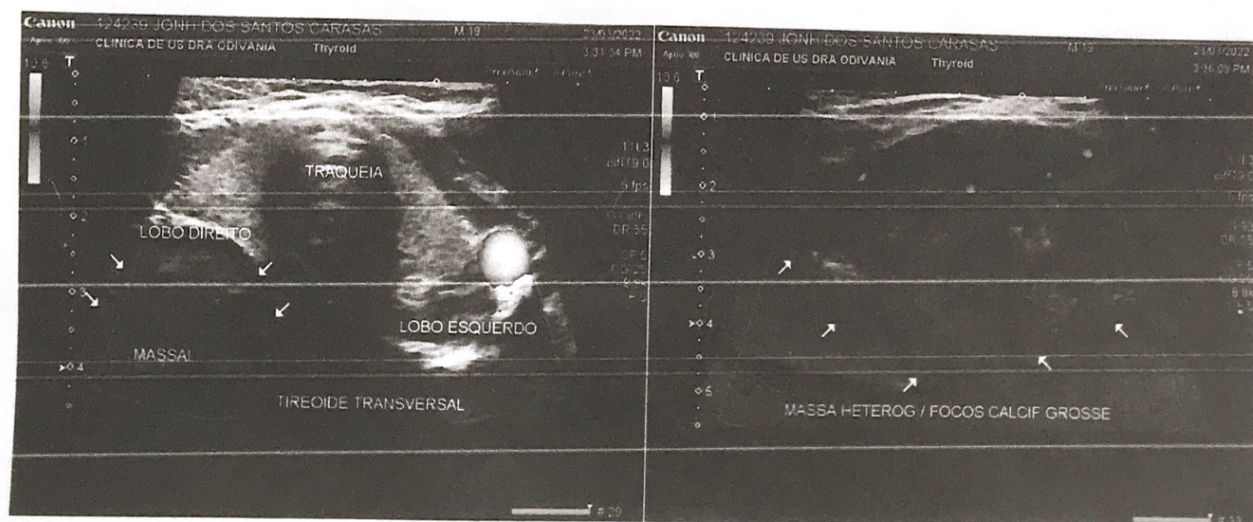
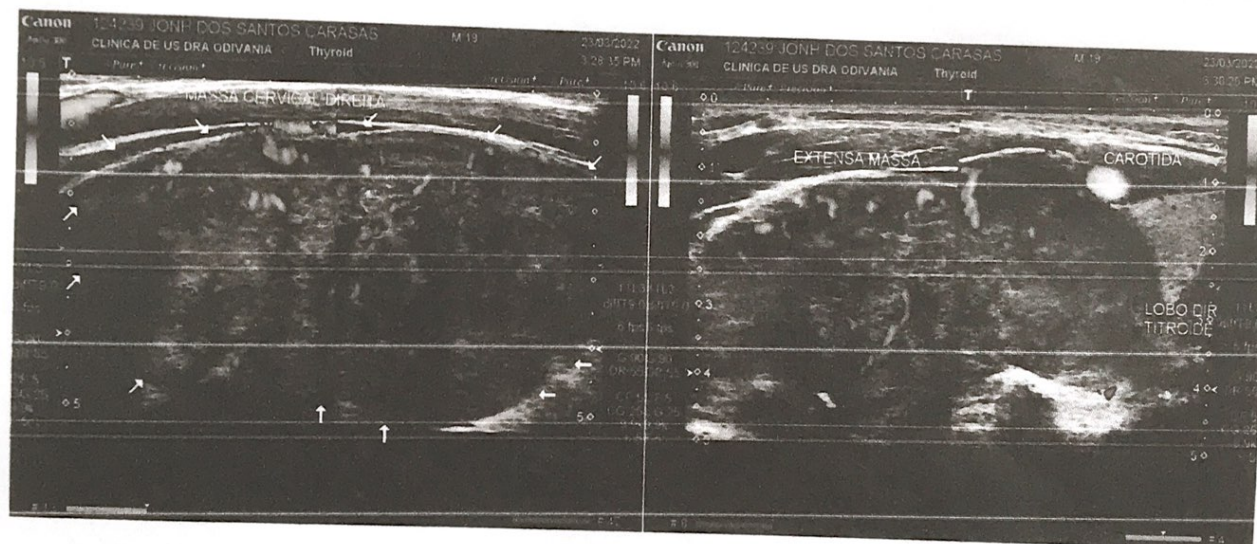
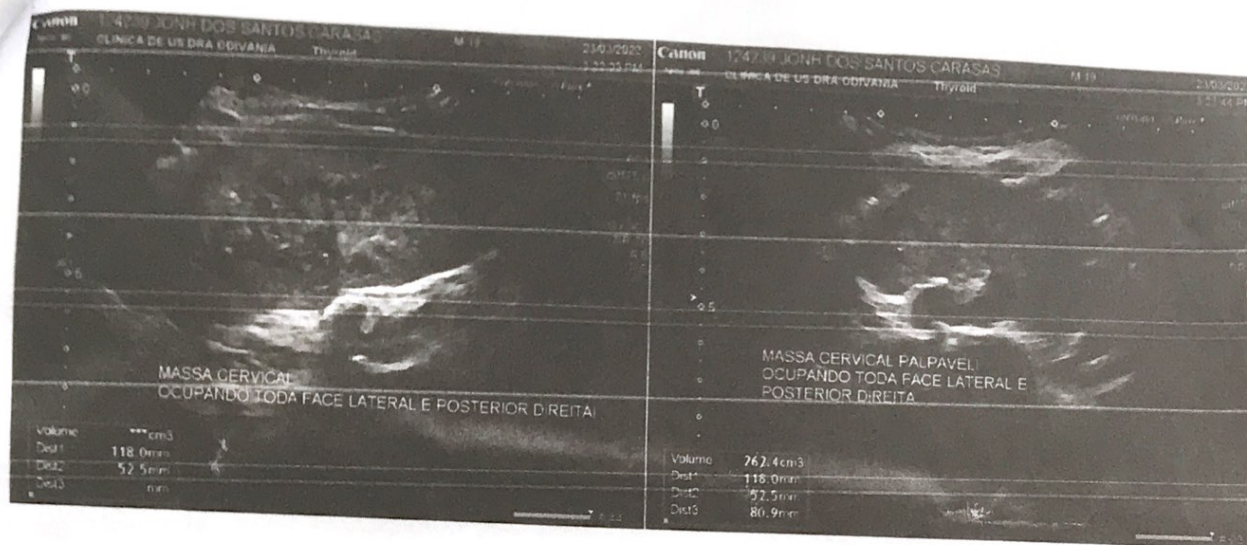
Obs.: sugere-se a avaliação do mediastino por outro método de imagem.

Em caso de retorno, favor trazer este laudo para comparação (o).


Dra. Odivânia Moscoliato
CRM: 76004

JONH DOS SANTOS CARASAS
Requisitante: WALNYR DE OLIVEIRA COSTA
Realizante: ODIVANIAMOSCOGLIATO

Data: 23/03/2022
Protocolo: 124239
Exame: DOPPLER DE TIREOIDE E



NOME: **JOHN DOS SANTOS CARAÇA**
SOLICITANTE: Dr(a): **EVANDRO LIMA E SILVA**
Prontuário: **1404131** Atendimento: **021 - 0291018** Data: **30/04/2022**

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE DA REGIÃO CERVICAL

TÉCNICA:

A presente avaliação foi realizada em aparelho tomográfico de multidetectores, sem e com a injeção intravenosa de contraste iodado hidrossolúvel não iônico, através de aquisição sequencial e volumétrica no plano axial.

As imagens adquiridas foram pós-processadas com reconstruções multiplanares e tridimensionais, com técnica de máxima intensidade de projeção e Volume Rendering.

Foram empregados parâmetros de redução de dose.

ANÁLISE:

Volumosa massa heterogênea com componente cranial no espaço retrofaríngeo, estendendo-se inferiormente ao longo da topografia paralaríngea direita, com componentes periféricos tangenciais aos forames de conjugação diretos no segmento entre C3 e C6, determinando discreto comprometimento osteolítico dos corpos de C2 e C3, apresentando pequenos componentes calcificados centrais e importante impregnação difusa e heterogênea pelo meio de contraste endovenoso. Suas dimensões estimadas são 7,9 x 5,3 x 10,8 cm (transverso, ântero-posterior e crânio-caudal).

Laringe e faringe rechaçados pela formação expansiva acima descrita, sem evidências de alterações nodulares luminais / intrínsecas.

Afilamento da coluna de fluxo da veia jugular interna direita, pelo efeito compressivo exercido pela massa cervical.

Planos adiposos e musculares focalizados de aspecto tomográfico normal.

Demais estruturas vasculares visibilizadas sem alterações.

Não se identificam alterações tomográficas na projeção da língua ou no assoalho da boca.

Glândulas submandibulares e parótidas sem sinais de lesões.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Volumosa massa heterogênea com componente cranial no espaço retrofaríngeo, estendendo-se inferiormente ao longo da topografia paralaríngea direita, com componentes periféricos tangenciais aos forames de conjugação diretos no segmento entre C3 e C6, determinando discreto comprometimento osteolítico dos corpos de C2 e C3, apresentando pequenos componentes calcificados centrais e importante impregnação difusa e heterogênea pelo meio de contraste endovenoso. Seus aspectos sugerem primariamente lesão proliferativa de origem neural. Sugere-se, correlação histopatológica.

Laringe e faringe rechaçados pela formação expansiva acima descrita, sem evidências de alterações nodulares luminais / intrínsecas.

Afilamento da coluna de fluxo da veia jugular interna direita, pelo efeito compressivo exercido pela massa cervical.

Faça também seus exames de sangue e laboratoriais conosco.

Rua Paraibuna, 811 - Jardim São Dimas, São José dos Campos-SP. 12245-020 - Telefone: (12) 3797-5411

PLONI

NOME: JOHN DOS SANTOS CARAÇA
SOLICITANTE: Dr(a): EVANDRO LIMA E SILVA
Prontuário: 1404131 **Atendimento:** 021 - 0291018 **Data:** 30/04/2022

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE DO TÓRAX

TÉCNICA:

A presente avaliação foi realizada em aparelho tomográfico de multidetectores, sem e com a injeção de contraste iodado, através de aquisição sequencial e volumétrica no plano axial.

As imagens adquiridas foram pós-processadas com reconstruções multiplanares e tridimensionais, com técnica de máxima intensidade de projeção e Volume Rendering.

Foram empregados parâmetros de redução de dose.

ANÁLISE:

Cavos axilares livres.

Fossas supraclaviculares sem evidências de alterações no presente estudo.

Coração de volume conservado e coeficientes normais de atenuações aos feixes de raios-X.

Os segmentos ascendente, transverso e descendente da aorta apresentam dimensões conservadas.

Tronco da artéria pulmonar e artérias pulmonares principais sem alterações significativas.

Ausência de derrame pleural.

Não há sinais de linfonodos aumentados de volume no mediastino.

Traqueia e brônquios principais de aspecto tomográfico conservado.

Não há evidências de focos de consolidações intraparenquimatosos ou de formações nodulares no presente estudo.

Nos cortes obtidos em expiração não identificamos áreas de aprisionamento aéreo.

Faça também seus exames de sangue e laboratoriais conosco.

Rua Paraibuna, 811 - Jardim São Dimas, São José dos Campos-SP, 12245-020 - Telefone: (12) 3797-5411

NOME: JOHN DOS SANTOS CARAÇA
SOLICITANTE: Dr(a): EVANDRO LIMA E SILVA
Prontuário: 1404131
Atendimento: 021 - 0291018
Data: 30/04/2022

AX
Laboratório
ma, 246 - Centro - São Jo.
Solicitante Dr. (a): JOHN DOS
Convenção: 23/11/2002
Local: EVANDRO
AIC

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Análise Tomográfica Computadorizada Multislice do Tórax sem evidências de anormalidades.

Filipe B. Cintra

Dr. Filipe Belmont Cintra - CRM 108929



Faça a leitura do QRCode
para visualização das imagens
deste Laudo

Faça também seus exames de sangue e laboratoriais conosco.

Rua Paraibuna, 811 - Jardim São Dimas, São José dos Campos-SP, 12245-020 - Telefone: (12) 3797-5411

Alt Gr

Ctrl

Dr. Abaeté L. Canto

Dr. Carlos Eduardo de Godoy
Dr. Vinícius Pereira Barros**AX**
Laboratório

Pens, 246 - Centro - São José dos Campos - SP

Praça Padre Anchieta, 130 - Centro - Jacareí - SP

SAC - (12) 3203-6632

Nome : JOHN DOS SANTOS CARACA
Data : 23/11/2002
Solicitante Dr. (a) : EVANDRO LIMA E SILVA
Convênio : AUSSEL
Local : CONS JACAREI

O.S. : 003-66245-244
CPF : 387.356.598-66
Atendimento : 16/05/2022 - 09:22:03
Qnt de exames : 1
Página(s) : 2/2
Rota : Local/Internet

COMENTÁRIO:

As características pertencem ao espectro diferencial de tumores com componente ou com diferenciação miofibroblástica sem atipias. Considerando adicionalmente alguns aspectos morfológicos mencionados, o conjunto dos achados levanta principal possibilidade de fibromatose de tipo desmóide. Esta hipótese deve ser confirmada com encontro de tumor usualmente apresentando dimensões significantes e envolvimento agressivo de estruturas adjacentes. Componente miofibroblástico, ou diferenciação miofibroblástica, de outras neoplasias mesenquimais benignas ou de baixo grau não pode ser afastados.

Roberto F.
DR. ROBERTO FAZOLINI
CRM 40173

Liberação: 13/06/2022

Diego H. Silva
DR. DIEGO HENRIQUE SILVA
CRM-SP 168660
RQE Nº: 93270 - PATOLOGIA

ASSINATURA DIGITAL
E8034DB3335A

Dr. Carlos Eduardo de Godoy (RT) - CRM 23267, Dr. Abaeté Leite do Canto (RT) - CRM 20821,
Dra. Mayara Boccalari A. Abrahão (RT) CRM 30656, Dra. Laura Gabrieli Portolan B. Brito (RT) CRM 90106

A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão do diagnóstico são atos médicos; dependem da análise conjunta dos dados clínicos, epidemiológicos e dos demais exames do(a) paciente.

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: JOHN DOS SANTOS CARAÇA			
Sexo: M	Idade: 20 anos	Peso: 83 Kg	Altura: 1,77 m
IMC: 26,5	Data do Exame: 20/03/2023	Exame: 12281_01	
Médico solicitante: DR MARIO SERGIO			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 21:00:47 horas e encerrado às 06:01:51 horas, com latência para o sono de 231 minutos e latência para o sono REM de 124 minutos. O tempo total de sono foi de 194,5 minutos, com eficiência do sono de 38,6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	9,8%	Até 5%
Estágio 2	59,6%	45 - 55%
Estágio 3	29,0%	> 15%
Sono REM	1,5%	20 - 25%
Eficiência do sono	38,6%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 259 minutos ocorreram **71 despertares (índice de 21,9/hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 84 bpm, a maior de 119 bpm e a menor de 58 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares**.

Ocorreram 123 eventos respiratórios, sendo 0 central e 123 obstrutivos. Sendo 104 apnéias, 19 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 37,9/hora**, sendo 32,1 apnéia/hora e 5,9 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 17,4 e a duração máxima de 40,4.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 20,0/hora, sendo 0,0 apnéia/hora e 20,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 94%**, sendo a saturação média de 93%, a maior de 97% e a mínima de 76%, permanecendo 12,4 minutos (2,5%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,1 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 55 dessaturações. Índice de dessaturações: 17,0/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 40,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 17,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Rosemery Tereza Marçal
 (Acrnologia)
 Distúrbios Respiratórios do Sono
 (CRM-SP 71200)

NOME: JOHN DOS SANTOS CARACA
D.N.: 23/11/2002
SOLICITANTE: FANNY G A CASCELLI
CONVÊNIO: BRADESCO SAUDE S/A
LOCAL: JACAREI

Q.S.: 296-66557-216
CPF: 387.356.598-66
ATENDIMENTO: 24/03/2023 - 09:09:38
QTD DE EXAMES: 9
PAGINA(S): 2/4

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Material: Soro

Método: Oxidação com vanadato

Coleta: 24/03/2023 - 09:18:33

Liberação: 24/03/2023 - 12:36:15

BILIRRUBINA TOTAL:

0,70 mg/dL

Valor de Referência:

0,3 a 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA:

0,20 mg/dL

Valor de Referência:

Até 0,30 mg/dL

BILIRRUBINA INDIRETA:

0,50 mg/dL

Valor de Referência:

Até 0,80 mg/dL

CREATININA

Material: Soro

Método: Creatinase

Coleta: 24/03/2023 - 09:18:33

Liberação: 24/03/2023 - 12:35:40

RESULTADO:

0,8 mg/dL

Valor de Referência:

0,6 a 1,1 mg/dL

POTÁSSIO

Material: Soro

Método: Eletrodo Seletivo

Coleta: 24/03/2023 - 09:18:33

Liberação: 24/03/2023 - 12:24:41

RESULTADO

5,0 mEq/L

Valor de Referência

3,5 a 5,5 mEq/L

Laudado liberado eletronicamente por Henrique Lino Bispo, CRBM 13393.

ASSINATURA DIGITAL

306A53EBC49604E305C501CF0FC6038B8A804ECFFDBD1E0F7274DE8C701F70F120CF5D72CF069B4

Dr. Carlos Eduardo de Godoy (RT) - CRM 23267

A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão do diagnóstico são atos médicos; dependem da análise conjunta dos dados clínicos, epidemiológicos e dos demais exames do(a) paciente.

pté asmático, → fez broncoespasmo, foi
até o Pneumologista (8 meses de
+to pl sinuíte / rinite) amigdalite
a D edemaciado (ele já não ouvia
mais o chiado). tomava antibio-
tico.

Ele trabalhando sentiu muita
dor no braço e tomou remédio
passou e a noite apareceu
uma massa a D na cervical.
Em 28 de março, 2022, ficou internado
colheu biópsia:

Sonoência 5 (1 Buva e 1/2)
Cansaço 5